



NVD & RMLG on 3/11/25 at 6-12pm

NATIONAL HEALTH MISSION

Andhra Pradesh



Sex-Mch
wt-3220 gm-

ICD Code :

Arogyasri Code :

L2 & L3 Facility - CHC/AH/MCH/DH/TH

Case Sheet for Maternity Services

Baby
Blood group = O+ve

O neg



LP

Age-28

sex-F

caste SC

Primigravida
Eg. Anti-D
Given on
3/11/25

Name

: Vangavarapu Sumathi

W/O or D/O

: Mallavarapu Basavaiah

IPD / Registration No.

: 18254 @ 5-00 pm at 3/11/25

Name of the facility

: vipparla (v) Rompicherla

Initial Diagnosis

: pt no - 6270 0090 2973

Final Diagnosis

: Ad no. 70 75331032

Type : CHC / AH / MCH/DH/TH :

20280098367



డైరక్టరేట్ ఆఫ్ సెకండరీ హెల్త్ ఆంధ్రప్రదేశ్

విజయవాడ పశువైద్యశాల, నరసరావుపేట.

O.P. TICKET / అవుట్ - పేషెంట్ టికెట్

పేరు: Sumathi

ఓ.పి. నెం.: 18254

వయస్సు: 28/F M/F:

తేదీ: 8/11/25

అధికారి: Dr. R. R. R.

వ్యాధి:

Investigations

CBC

HB %

ESR

Alb

Urine Sug

Micro

Hbs Ag.

HCV

RBS

BI Group/Rh type

ICTC

VDRL

Malaria

Widal

Dengue

RFT

LFT

Others

Complaints / Diagnosis

Dr. R. R. R.

Alb

Urine Sug

Hbs Ag.

HCV

RBS

BI Group/Rh type

ICTC

VDRL

Malaria

Widal

Dengue

RFT

LFT

Others

Complaints / Diagnosis

Drug Name	Route	Freq			Total
		ద్వి	మూ	సా	

Signature
(Dr. Name with Stamp)

Time :

Time :

Time :

Time :

OP Registration

Dr. Consultation

Investigations

Dispensary

Procedures (Dressing / Injection)

సర్టిఫికేట్

పరీక్షించు డాక్టర్

కె.టి.ఎస్.

ఓ.పి. నెం.: 2807

తేదీ: 3/11/25

Hosp. :

నె.ఎ.లాబర్

Route	Freq			Total
	ద్వి	మూ	సా	
Term pregnancy				
= 30 Ann				
Dilatation				
used slowly				
to look off				
supernumerary				
2nd O				
to be performed				
by Ashwini				

Time :

Dispensary

Final outcome: Discharge / Death / LAMA / Abortion

*Referral during labour / Referral post delivery

Name and signature of service provider:

Designation:

Phone No: Date & Time:

*(If inreferred, attach the referral slip to case sheet)

SHEET FOR PRE DELIVERY NOTES

31/1/25
58m

38mi c 74 c cephalic presentation

BIA: wt 36-38w
cephalic
FHS ⊕

gc = mild paillo ⊕

Temp ⊕

BP = $\frac{110}{80}$ mmHg

PR = 82/min

PLV: 80% effaced
4

os = 6cm dilated

PPVx, membr ⊕

USG

cephalic
FHS ⊕

AFI = 4cm

2

2
① UP
② start PHS/
PFMC
monitoring

③ Inf monocub
IV BD

④ Inf Pantop
IV BD

⑤ IV - 10 RL

⑥ BP / TPR
monitoring

SHEET FOR PRE DELIVERY NOTES

3/11/25
6:12 pm

Delivery Notes
FTVD + RMLE

LSAP, Patient placed in lithotomy position. Parts Painted & draped. Inf 1% xylocaine is infiltrated over perineum. RMLE given. She delivered an single live, mch cwt = 3220 gms @ 6:12 pm on 3/11/25. liquor clear. placenta delivered by CRT & counter traction. All membranes & cotyledons are intact complete hemostasis secured uterus retracted well. RMLE closed in layers

Gc = Fair

Temp (N)

BP = $\frac{110}{80}$ mmHg

PR = 82/min

PLA: ut retracted well

PLV: BWNL

- ① Normal diet
- ② T. amoxiclav 625 mg BD
- ③ T. metrogyl 400 mg TID
- ④ T. Pantop 40 mg BD
- ⑤ T. Diclo BD
- ⑥ T. serraxbole BD
- ⑦ W/F Bleeding plv
- ⑧ BP / TPR Monitoring

SHEET FOR PRE DELIVERY NOTES

8/11/25

6 PM

primi 2 TG 2 cephalic
presentin

ge = mild pallor ⊕

Temp (N)

BP = $\frac{110}{80}$ mmHg

PR = 82/min

PIA = ut 36-38w
cephalic
FHS ⊕

- ① up
② start FHS/
DFMC
monitoring
③ SVT-100

PIV = ex = bulky abraded
os = bulky dilated

PPVx stat d'

membranes ⊕

pelvis < Gynecoid
&
Adequate

సామాజిక అంగీకార పత్రము

1. పేరు : లింగం : పు / స్త్రీ (రోగికి గల సంబంధం) అను నేను (రోగి పేరు / అంగీకారము ఇచ్చు వారి పేరు) :
 జనరల్ / జిల్లా / ఏరియా / సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రం / ఆసుపత్రి ఫోన్ నం.
 తెలియజేయుచున్నాను / ము. ఈ ఆసుపత్రి నందు వైద్యులు, నర్సులు మరియు ఆసుపత్రిలో అడ్మిట్ / చేరుటకు సంపూర్ణ అంగీకారము
 అనునంది అవశ్యకత ఉన్న విధంగా నా సామాజిక అంగీకారము / సహజ కానుపు / మత్తు ఇచ్చుట కొరకు / సిజేరియన్ / అసిస్టెడ్ డెలివరీ
 / చేయించుకోవడానికి నా / మా ఇష్టముతో నా / మా సంపూర్ణ అంగీకారము తెలుపుతున్నాను / ము.
 ఈ ఆసుపత్రి యందు నా / మా రోగి యొక్క వైద్యం మరియు ఇతర సేవల కొరకు మరియు దాని అనుబంధమైన భౌతిక పరీక్షలు,
 ప్రయోగశాల పరీక్షలు, ఔషధాలు / మందులు / మత్తు ఇవ్వడం / రేడియోలజీ (ఎక్స్రే / సిటిస్కాన్ / ఎమ్.ఆర్.ఐ పరీక్షల కొరకు / ఇతర
 ప్రవేశము కొరకు జాయిన్ చేయుట కొరకు నేను / మేము సంపూర్ణ అంగీకారము తెలియజేయుచున్నాను / ము.
 నా / మా వైద్యం కొరకు డాక్టరు గారు / ఆసుపత్రి సిబ్బంది నాకు / మాకు చికిత్స యొక్క వైద్య ప్రక్రియ యొక్క పూర్తి వివరాలు,
 డిహించగల పరిణామాలు (ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్కమ్స్) సంభవించవచ్చే తీవ్రమైన సమస్యలు నాకు తెలిసిన బాషలో పూర్తిగా నాకు వివరించారు,
 మరియు నాకు / మాకు పూర్తి అర్థమయ్యినది.
 4. ఎట్టి పరిస్థితులలో ఇప్పుడు కాని, భవిష్యత్తులోకాని సంబంధిత డాక్టర్లను, ఆసుపత్రి ఉద్యోగులను మరియు ఈ హాస్పిటల్ నా / మా
 రోగి యొక్క వైద్య విధాన ప్రక్రియలో / నిర్వహణ విధానంలో అనుకోకుండా సంభవించే డిహించని తీవ్ర నష్టము కల్గించే ఫలితాలు
 వెలునపుడు నేను పైన ఉదహరించిన డాక్టర్లు / మరియు ఆసుపత్రి సిబ్బందిని బాధ్యులను చేయ్యను / చేయ్యము. ఇందు పూర్వకముగా నా /
 మా అంగీకారము తెలుపుచున్నాను / ము.
 రోగి పేరు రోగి సంతకము / వేలిముద్ర :
 బంధువు / భర్త / రోగి సహాయకుని / గాలు పేరు / గార్డియన్ పేరు :
 సంతకము / వేలిముద్ర :
 డాక్టర్ పేరు మరియు హోదా సంతకం
 తేది సమయం స్థలం

మత్తు/ప్రమాద తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న సహజకానుపు/సిజేరియన్/అసిస్టెడ్ డెలివరీ/పి.పి.ఐ.యు.సి.డి. కొరకు అంగీకార పత్రము

1. పేరు : లింగం : పు / స్త్రీ (రోగికి గల సంబంధం) అను నేను (రోగి పేరు / అంగీకారము ఇచ్చు వారి పేరు) :
 జనరల్ / జిల్లా / ఏరియా / సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రం / ఆసుపత్రి ఫోన్ నం.
 తెలియజేయుచున్నాను / ము. ఈ ఆసుపత్రి నందు వైద్యులు, నర్సులు మరియు ఆసుపత్రి సిబ్బంది వారి పర్యవేక్షణ మార్గదర్శకత్వాన్ని
 అనునంది అవశ్యకత ఉన్న విధంగా నా అంగీకారమును సహజ కానుపు / మత్తు ఇచ్చుట కొరకు / సిజేరియన్ / అసిస్టెడ్ డెలివరీ /
 పి.పి.ఐ.యు.సి.డి. చేయించుకోవడానికి నా / మా ఇష్టముతో నా / మా సంపూర్ణ అంగీకారము తెలుపుతున్నాను / ము.
 2. మత్తు డాక్టరు మరియు వారి బృందము అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికీ అనస్థీసియా / మత్తు / నొప్పి నివారకములు ఇచ్చినపుడు
 ఈ క్రింది సమస్యలు అనగా ఐ.వి. పెట్టినపుడు ఏర్పడు సమస్యలు, తాత్కాలికంగా జ్ఞాపక శక్తి తగ్గుట, అవయవాలు పనితీరు సమతుల్యత
 కోల్పోవుట, వికారం, వాంతులు తలనొప్పి, గొంతు సమస్యలు, కండరాల నొప్పి శరీరము కండడం లేదా వాపు మొదలగున్నవి జరగవచ్చునని
 నాకు / మాకు వివరించడమైనది. మరియు పేషెంటుకు ట్యూబు వేయునపుడు, అనస్థీసియా ఇచ్చినపుడు పేషెంట్ నోటిలో వదులుగా
 మరియు పొడైన పళ్ళు, కృత్రిమ పళ్ళు ఊడిపోవుటకు ఆస్కారము కలదని వివరించడమైనది.
 3. రక్త హీనత / అధిక రక్తపోటు / మధుమేహం / గర్భనంచి అధికముగా వ్యాకోచించి ఉండడం / కవల పిల్లలు / ఉమ్మనీరు
 తక్కువగా ఉండడము వలన సహజ కానుపు / సిజేరియన్ / అసిస్టెడ్ డెలివరీ సమయములో మరియు తరువాత నాకు, పుట్టబోయే బిడ్డకు
 లేదా ఇరువురికి ప్రమాదము జరిగే అవకాశము ఎక్కువగా ఉన్నది అని తెలిపియున్నాను.
 4. నేను / మేము పైన సూచించిన / ఉదహరించిన విషయాలన్నింటికి నేను / మేము పూర్తి స్పృహలో ఉండి మనస్ఫూర్తిగా ఇచ్చిన
 అంగీకార పత్రము ఇది అని దృవీకరించుచున్నాను / ము.
 రోగి పేరు రోగి సంతకము / వేలిముద్ర :
 బంధువు / భర్త / రోగి సహాయకుని / గాలు పేరు / గార్డియన్ పేరు :
 సంతకము / వేలిముద్ర :
 డాక్టర్ పేరు మరియు హోదా సంతకం
 తేది స్థలం

Dr. D. MADHAVI LATHA
 Regd. No. 48219
 G.S. Gynaecologist
 Area Hospital, NARASARAOPET.

ulularPND-1Le @ diet
cr @ Q

ac wild paller @

BP: 110/70 mm Hg

PR: 92/mt

PLA: at retracted well

plu BWL

5/11/15PND-1Le @ diet
cr @ Q

ac wild paller @

BP: 110/80 mm Hg

PR: 96/mt

PLA: at retracted well

plu BWL

Indication for CS
(Refer table below)

Other Notes:

6/11/25

3111-110

G1 - Mild Pelvic
BP 110/60 mm
PR 12 by
type
Placenta previa
placenta

1st time let
2nd

B

Please tick the relevant indications. You may choose multiple reasons.

Sl no	Indication for CS	Sl no	Indication for CS
1	Abdominal cerclage	14	IUGR, Doppler compromise
2	Abnormal lie	15	Maternal request
3	Abnormal presentation: breech or transverse, oblique	16	Others (mention)
4	Abruptio Placenta	17	Pelvis tumours as a contraindication to delivery
5	Adherent Placenta	18	Placenta praevia
6	Bad obstetric history	19	Presumed fetal compromise - Abnormal CTG - Meconium stained liquor - Abnormal CTG + Meconium stained liquor
7	Cephalo-pelvic disproportion (Previous LSCS for CPD)	20	Previous preterm caesarean section / hysterotomy / myomectomy / upper segment caesarean section
8	Cord prolapse / presentation	21	Previous uterine surgery (other than CS)
9	Failed induction	22	Rh ISO immunization
10	Failure to Progress	23	Suspected scar dehiscence
11	HELLP syndrome	24	Twin pregnancies (1 non cephalic)
12	Higher order multiples (triplets or more)	25	Two previous LSCS or more
13	HIV positive	26	Vaginal lesion / infection as a contraindication to vaginal delivery